

Les Purpuras.

Etiopathogénie, Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

Pr Ag Amira Atig

Cas clinique1: Patient âgé de 58 ans, tabagique et hypertendu sous traitement non précisé, est adressé aux urgences pour la prise en charge d'un purpura évoluant depuis 72 heures. A l'examen physique, le patient est apyrétique, présence de lésions de purpura des membres inférieurs infiltrées et nécrotiques par endroit, Aspect marbré avec présence d'un réseau erythrocyanique au niveau des cuisses, TA = 20/10. A la biologie : VS à 80 mm à H1, hyperleucocytose à PNN à 12000 éléments /mm³, insuffisance rénale à 200 µmol/l, protéinurie des 24 h négative. L'échographie rénale est sans anomalies.

1. Quels sont les diagnostics à évoquer en premier ?
 - A. Un myxome de l'oreillette
 - B. Une dermatomyosite
 - C. Une embolie graisseuse
 - D. Une maladie d'embolies de cristaux de cholestérol
 - E. Un purpura rhumatoïde
2. Les mécanismes aboutissant au purpura sont:
 - A. Un purpura vasculaire
 - B. Un purpura par fragilité capillaire
 - C. Un purpura embolique
 - D. Une vascularite d'hypersensibilité
 - E. Un purpura thrombotique
3. Quels sont les facteurs déclenchants qu'il faudra rechercher :
 - A. Un geste chirurgical vasculaire
 - B. Une mise en route d'un traitement par AVK
 - C. La mise en place d'un cathéter artériel
 - D. Une infection virale récente
 - E. Une prescription d'antibiotiques

Cas clinique 2 : Patiente âgée de 28 ans aux antécédents familiaux de maladie coéliqua chez une cousine et un lupus érythémateux systémique chez une sœur, consulte pour des lésions purpuriques pétéchiales généralisées évoluant depuis une semaine associées à une épistaxis bilatérale et des lésions ecchymotiques. Elle rapporte par ailleurs, des arthralgies inflammatoires des grosses articulations et une sécheresse oculaire.

1. Il s'agit vraisemblablement d'un purpura thrombopénique devant:
 - A. Le caractère monomorphe
 - B. Les lésions diffuses
 - C. La présence des signes extra- cutanés
 - D. L'âge
 - E. Les antécédents familiaux

2. La conduite à tenir thérapeutique en urgence dépendra de:

- A. Taux de plaquettes
- B. La présence d'un saignement digestif associé
- C. Le caractère diffus des lésions purpuriques
- D. L'âge
- E. La présence d'une hématurie microscopique

3. Le traitement à prescrire chez la patiente serait :

- A. Des échanges plasmatiques
- B. Une corticothérapie
- C. Des immunoglobulines
- D. Un anti CD 20 (Mabthera®)
- E. Une splénectomie

Cas clinique 3: Patient âgé de 34 ans sans antécédents pathologiques qui consulte pour des troubles de conscience d'installation brutale évoluant depuis 48 heures. L'examen physique, objective une pâleur cutanéomuqueuse, une dysarthrie et quelques lésions purpuriques des membres inférieurs. Le reste de l'examen est sans anomalies.

A la biologie, hémoglobine à 8g/dl avec VGM: 85 fl; TCMH: 27 pg/l, réticulocytes : 160 000 éléments / mm³, plaquettes : 52000 éléments /mm³ et des globules blancs à 6000 éléments /mm³, créatininémie : 320 µmol/l, TP : 85 %

1. Le tableau clinico-biologique évoque en premier:

- A. Un syndrome de Moschowitz
- B. Un purpura thrombopénique immunologique
- C. Une coagulation intravasculaire disséminée
- D. Un purpura fulminans
- E. Une endocardite infectieuse

2. Le mécanisme expliquant la thrombopénie dans ce cas est:

- A. Une hyperconsommation
- B. Un excès de destruction périphérique
- C. Une anomalie de répartition des plaquettes
- D. Une hémodilution
- E. Un défaut d'expression du complexe GPIIb IIIa membranaire plaquettaire

3. Quel(s) examen(s) complémentaire (s) demander pour confirmer votre hypothèse :

- A. Le dosage de l'activité de l'ADAMTS-13
- B. Le frottis sanguin
- C. Une ponction sternale
- D. Une tomodensitométrie cérébrale
- E. Une biopsie cutanée avec IFD

Cas clinique 4

Patiente âgée de 65 ans suivie pour hypertension artérielle et insuffisance cardiaque bien équilibrée sous son traitement prescrit depuis 4 ans qui consulte pour une douleur abdominale diffuse et des polyarthralgies inflammatoires des grosses articulations évoluant depuis 7 jours. On note, la présence aux membres et à l'abdomen de lésions érythémato-violines infiltrées non nécrotiques ne s'effaçant pas à la vitropression confluentes en plaques par endroits avec présence de phlyctènes. Le reste de l'examen physique est sans particularités. Au bilan :

NFS : Hb =9 ; VGM= 80; TCMH=27; Pq=250000; créatinémie= 125, bilan hépatique correct

1. Quel diagnostic vous semble le plus probable,
 - A. Une hémopathie
 - B. Un purpura rhumatoïde
 - C. Une endocardite infectieuse
 - D. Une toxidermie
 - E. Un pemphigus bulleux

2. Quels examens complémentaires faut-il demander de 1 ère intention
 - A. Une biopsie cutanée avec IFD
 - B. Une échographie cardiaque
 - C. Des sérologies virales
 - D. Une protéinurie des 24h
 - E. Un myélogramme

3. Quelles complications doit-on craindre en premier chez cette patiente ?
 - A. Une perforation digestive
 - B. Un sepsis
 - C. Un œdème aigu des poumons
 - D. Une insuffisance cardiaque décompensée
 - E. Une embolie pulmonaire

4. Quels traitements étiologiques peuvent être envisagés chez cette patiente ?
 - A. Une corticothérapie systémique
 - B. Une antibiothérapie probabiliste
 - C. Une anticoagulation préventive
 - D. Colchicine
 - E. Des immunoglobulines intra-veineux

Cas clinique 5:

Patient âgé de 26 ans, sans antécédents pathologiques, consulte pour des polyarthralgies des genoux et des chevilles évoluant depuis quelques jours associées à des douleurs abdominales péri-ombilicales. Le patient rapporte qu'il a présenté une rhinorrhée et une odynophagie une semaine avant son hospitalisation. A l'examen, on note la présence de lésions érythémato-violines ne s'effaçant pas à la vitro-pression, polymorphes, nécrotiques par endroit, infiltrées, prédominant aux membres inférieurs et majorées par l'orthostatisme ainsi que des arthrites au niveau des chevilles. Le reste de l'examen physique est sans particularités. La NFS, la créatinine et la fonction hépatique sont normales.

5. Lequel des diagnostics suivants vous semble le plus probable ?
 - A. Un purpura thrombopénique idiopathique
 - B. Une cryoglobulinémie
 - C. Une toxidermie
 - D. Un purpura rhumatoïde
 - E. Une hémopathie
6. Le mécanisme aboutissant à cette hypothèse est:
 - A. Une thrombopathie constitutionnelle
 - B. Une thrombopénie centrale
 - C. Un déficit en facteur de Willebrand
 - D. Une vascularite médiée par des immunoglobulines
 - E. Une vascularite infectieuse
7. Quels sont les arguments qui permettront de conforter votre hypothèse ?
 - A. Les données cliniques
 - B. Les dépôts d'IgA en péri-vasculaire
 - C. L'élévation possible des IgA sériques
 - D. L'abaissement du complément (C3, C4)
 - E. La présence du facteur rhumatoïde
8. Quelle est la complication redoutable chez ce patient?
 - A. Une perforation digestive
 - B. Une méningite
 - C. Une arthrite septique
 - D. Un infarctus de myocarde
 - E. Un accident vasculaire cérébral

QCM:

1. Le purpura
 - A. Pose un problème de diagnostic positif
 - B. Impose une enquête étiologique
 - C. Est de diagnostic histologique
 - D. signe un trouble de l'hémostase secondaire
 - E. Est de mécanisme variable
2. Le purpura vasculaire
 - A. Est lié à des anomalies qualitatives des plaquettes
 - B. Résulte de mécanisme inflammatoire ou non inflammatoire
 - C. Est dit inflammatoire en présence d'une biopsie cutanée normale
 - D. Peut être iatrogène
 - E. Nécessite un traitement urgent quelque soit son étiologie

3. Le purpura vasculaire
 - A. Touche les muqueuses
 - B. Evolue par poussées
 - C. Peut se compliquer de nécrose
 - D. Est non infiltré
 - E. Est monomorphe

4. Le purpura
 - A. Fait intervenir globules rouges et vaisseaux
 - B. Est un symptôme clinique
 - C. Menace le pronostic quand il s'associe à un syndrome méningé
 - D. Impose la pratique d'un TCA en urgence
 - E. Peut être satellite d'une affection héréditaire

5. Un purpura vasculaire est caractérisé sur le plan clinique par :
 - A. L'aspect plan non palpable
 - B. Le caractère déclive des lésions purpuriques
 - C. L'aspect polymorphe des lésions
 - D. L'association à des gingivorragies et/ou epistaxis
 - E. L'effacement des lésions par la vitro-pression

6. Les éléments de gravité d'un purpura sont
 - A. Les âges extrêmes
 - B. La prise d'un AVK
 - C. Une thrombopénie inférieure à 50000
 - D. Une hématurie microscopique
 - E. Un TP bas

7. Quels sont les éléments de gravité d'un purpura?
 - A. Une thrombopénie $< 50\,000/\text{mm}^3$
 - B. Une hémorragie rétinienne
 - C. Un purpura bulleux
 - D. Un âge jeune
 - E. Une oligoanurie

8. Le score hémorragique de Khellaf
 - A. Evalue la gravité d'un purpura chez l'enfant
 - B. Est coté de Grade 0 au grade 5
 - C. Un grade ≥ 3 signifie un risque fonctionnel ou vital immédiat
 - D. Est coté à 15 en présence d'une atteinte de système nerveux central
 - E. S'applique pour le purpura vasculaire

9. Un score hémorragique de Buchanan est dit grade 4 en présence de
- A. Rares pétéchies sur la peau
 - B. Saignement buccal actif intermittent
 - C. Epistaxis répété
 - D. Pétéchies au palais
 - E. Sang dans une narine
10. Au cours du purpura fulminans, le purpura :
- A. Est dû à une destruction périphérique excessive
 - B. Est d'apparition brutale
 - C. Est symétrique
 - D. Est acral avec une évolution centripète
 - E. A une évolution bénigne
11. Le diagnostic positif d'une thrombopénie nécessite
- A. La vérification du nombre des plaquettes sur frottis et sur tube citraté
 - B. L'exclusion d'agrégats plaquettaires sur le prélèvement.
 - C. La présence d'un syndrome hémorragique clinique
 - D. La pratique d'une ponction sternale
12. La thrombopénie périphérique est secondaire à
- A. Une anomalie quantitative ou de la mégacaryopoïèse
 - B. Un hypersplénisme
 - C. Une anomalie qualitative des plaquettes
 - D. Une hémodilution
 - E. La présence d'auto-anticorps
 - E. La confirmation sur un 2^{ème} prélèvement
13. Le purpura thrombopénique:
- A. Est infiltré et palpable
 - B. Est déclive
 - C. S'associe à un syndrome hémorragique
 - D. Est diffus
 - E. Evolue par poussées
14. Les médicaments pouvant entraîner une thrombopénie par mécanisme immuno-allergique sont :
- A. Phénylbutazone
 - B. Pénicilline
 - C. Isoniazide
 - D. Les diurétiques thiazidiques
 - E. L'héparine

15. Le purpura thrombopénique auto-immun
- A. Est fréquent chez l'enfant
 - B. Est dit chronique quand la thrombopénie persiste plus de 2 ans
 - C. Est un diagnostic d'élimination
 - D. A une évolution chronique à rechutes chez l'enfant
 - E. Est confirmé par la présence d'anticorps anti-plaquettes à la biologie
16. Une thrombopénie de mécanisme central se voit au cours
- A. D'une leucémie aigue
 - B. D'un hypersplénisme
 - C. D'une amégacaryocytose auto-immune
 - D. D'une micro-angiopathie auto-immune
 - E. D'un purpura fulminans
17. La thrombasthénie de Glanzman:
- A. Est due à un déficit du complexe de GPIb membranaire plaquettaire
 - B. Est de transmission autosomique récessive
 - C. Donne une thrombopénie modérée et des plaquettes de grande taille au frottis
 - D. Est confirmée par la cytométrie de flux
 - E. Donnent un TP et un TCA normaux
18. L'association d'un purpura à un livédo et à une nécrose d'un orteil est évocatrice de :
- A. Déficit en inhibiteurs de coagulation
 - B. Cryoglobulinémie
 - C. Une embolie graisseuse
 - D. Syndrome des antiphospholipides
 - E. syndrome de Gardner Diamond
19. Un purpura par fragilité capillaire :
- A. Se voit exclusivement chez le sujet âgé
 - B. Est de mécanisme inflammatoire
 - C. Peut être d'origine médicamenteuse
 - D. Complique une hypovitaminose C
 - E. Se traduit histologiquement par un infiltrat inflammatoire lymphocytaire
20. Le purpura de Bateman
- A. Est un purpura par fragilité capillaire
 - B. Peut être engendré par une corticothérapie prolongée
 - C. Est un purpura vasculaire sénile
 - D. Siège préférentiellement au niveau des membres inférieurs
 - E. Se traite par les corticoïdes

21. Le syndrome de Gardner Diamond:
- A. Se manifeste par des ecchymoses douloureuses
 - B. Se voit chez des femmes névrotiques
 - C. Réalise un purpura par fragilité capillaire
 - D. Est déclenché par un effort important
 - E. Se traite par les corticoïdes
22. La granulomatose avec polyangéite :
- A. Est anciennement appelée syndrome de Churg Strauss
 - B. Associe un asthme tardif et sévère avec hyper éosinophilie sanguine et tissulaire
 - C. Donne une atteinte ORL au 1^{er} plan
 - D. Est caractérisée par des ANCA positifs dans 80 % des cas
 - E. Est une vascularite systémique primitive
23. La granulomatose éosinophilique avec angéite
- A. Est une vascularite systémique primitive de gros vaisseaux
 - B. Donne une éosinophilie sanguine exclusive
 - C. Associe un asthme tardif et sévère avec hyper éosinophilie sanguine et tissulaire
 - D. Est caractérisée par des ANCA de type anti-myéloperoxydases (MPO) et de fluorescence périmucléolaire ou pANCA.
 - E. Est une vascularite systémique secondaire
24. Le purpura rhumatoïde
- A. Est une connectivite
 - B. Est une vascularite des gros vaisseaux
 - C. Est fréquente chez l'enfant
 - D. Associe des atteintes articulaire, rénale, digestive et un purpura
 - E. Peut être précédé par une infection ORL
25. Le syndrome des anti-phospholipides
- A. Est de diagnostic clinique
 - B. Est un syndrome de définition clinico-biologique
 - C. Est à l'origine d'un Purpura Vasculaire Non Inflammatoire
 - D. Est une cause de purpura embolique
 - E. Est caractérisé sur le plan clinique par des manifestations obstétricales et/ou thrombotiques
26. Un purpura thrombopathique:
- A. Est plus fréquemment d'origine constitutionnelle
 - B. Peut être secondaire à une cirrhose
 - C. Complicque une prise prolongée d'acide acétylsalicylique
 - D. Est confirmé par une baisse du temps d'occlusion plaquettaire
 - E. Associe un purpura et un syndrome hémorragique

27. Les thrombopathies acquises

- A. Sont rares
- B. Sont peu symptomatiques
- C. Peuvent être secondaires à la prise d'Acide acétylsalicylique
- D. Se voient au cours d'une thrombasthénie de Glanzman
- E. Sont liées à une anomalie quantitative des plaquettes

28. Les indications du traitement au cours du purpura thrombopénique auto-immun sont:

- A. Un nombre de plaquettes $< 30\,000 /\text{mm}^3$ avec saignement
- B. Avant un geste chirurgical
- C. La grossesse
- D. Les antécédents de coronaropathie
- E. La prise d'un anti-agrégant plaquettaire

29. Le traitement de 2^{ème} ligne du purpura thrombopénique auto-immun repose sur:

- A. Les immunoglobulines intraveineuses
- B. Les corticoïdes
- C. La splénectomie
- D. Les agonistes du récepteur de la thrombopoïétine
- E. Un traitement immunosuppresseur

30. Le traitement d'un purpura vasculaire

- A. Dépend de l'étiologie sous jacente
- B. Consiste à une corticothérapie de 1^{ère} intention
- C. Peut être un repos au lit isolé
- D. Repose sur les échanges plasmatiques en cas des vascularites à ANCA
- E. Fait appel à la colchicine en cas de rechute

31. Le traitement du purpura thrombotique thrombocytopénique

- A. Est une urgence
- B. Fait appel aux échanges plasmatiques à la phase aiguë
- C. Repose sur les anti CD20 à la phase aiguë
- D. Comporte les antiagrégants plaquettaires
- E. Repose sur les transfusions de plaquettes à la phase aiguë